

Equipe Nexo

A prática depende de um abastecimento viável

“Leve as perguntas com você. Este material reúne os conceitos e o caso para que você continue a discussão depois do jogo.” — Iris

O problema que investigamos

Na clínica cirúrgica, duas de quatro equipes elegíveis iniciaram o protocolo. O abastecimento é irregular e buscar materiais consome tempo. Um estoque maior resolve parte do problema, mas pode aumentar perdas e custos.

Objetivos da missão

- Distinguir início de adoção e execução cotidiana
- Negociar uma estratégia compatível com recursos e fluxo
- Avaliar adoção, viabilidade e custo de implementação

Dados iniciais do caso fictício

Medida	Dado	O que representa
Equipes que iniciaram	2/4	Equipes elegíveis; início de uso, não execução contínua
Abastecimento incompleto	3/10 dias	Dias do período observado com falta de pelo menos um material previsto
Busca de material	14 min	Mediana de tempo por busca nas 12 buscas acompanhadas
Custo adicional do piloto	R\$ 480	Estimativa fictícia inicial; ainda sem tempo de trabalho e desperdício

Simulação educacional. Dados, pacientes e personagens fictícios. As aplicações dos referenciais são interpretações didáticas, não recomendações clínicas ou um instrumento validado.

Do conhecimento à mudança

Knowledge-to-Action

O KTA articula criação do conhecimento e um ciclo de ação. Identificar a lacuna, adaptar ao contexto, investigar barreiras, escolher estratégias, monitorar, avaliar e sustentar são atividades que podem ser revisitadas.

No seu caso: Investigar demanda e reposição permite adaptar o piloto aos recursos reais.

Evite: Tratar o ciclo como uma lista rígida ou presumir que publicar o protocolo encerra a implementação.

Base: Graham et al., 2006

CFIR atualizado

O CFIR organiza determinantes em cinco domínios. Serve para investigar barreiras e facilitadores; não escolhe automaticamente a estratégia nem substitui a avaliação dos resultados.

Domínios: inovação; contexto externo; contexto interno; indivíduos; processo.

No seu caso: Criar estoque é estratégia; falta de recursos e fluxo inadequado são possíveis determinantes.

Evite: Confundir uma barreira com a estratégia para enfrentá-la, ou classificar um relato sem definir o contexto do projeto.

Base: Damschroder et al., 2022; Reardon et al., 2025

PARIHS e i-PARIHS

O PARIHS destaca evidência, contexto e facilitação. O i-PARIHS articula inovação, destinatários e contexto por meio da facilitação ativa: avaliar necessidades, alinhar condições e apoiar a mudança.

A facilitação exige ações: avaliar necessidades, negociar condições, preparar pessoas e acompanhar a incorporação. Nomear alguém não equivale a facilitar.

No seu caso: Apoiar a negociação entre abastecimento, destinatários e liderança conecta condições e prática.

Evite: Designar uma facilitadora e presumir que o cargo, sem ações e apoio, resolve a implementação.

Base: Harvey e Kitson, 2016

Planejar e avaliar com RE-AIM

O RE-AIM apoia planejamento e avaliação em níveis individual e organizacional. Definam unidade de análise, numerador, denominador, fonte e momento; investiguem também representatividade.

Dimensão	Pergunta de estudo
Alcance	Participação e perfil das pessoas destinatárias.
Efetividade	Efeitos da intervenção, inclusive indesejados.
Adoção	Participação de serviços e profissionais que iniciam a prática.
Implementação	Execução, adaptações e custos.
Manutenção	Continuidade em níveis individual e organizacional.

Aplicação à missão

Adoção simulada: 3/4 equipes = 75%. Investigue quem iniciou e quem ficou de fora. A medida não comprova execução consistente. Os R\$ 720 observados incluem materiais, tempo e perdas; a composição da estimativa inicial precisa ser explicitada.

Ficha de um indicador

Registre: dimensão ou desfecho; unidade de análise; numerador; denominador; fonte; momento; responsável; critério para revisar o plano. Analise quem ficou de fora e os efeitos indesejados.

Usar uma taxa global para ocultar grupos não alcançados, ou confundir adoção inicial com continuidade.

Base: Glasgow et al., 2019. As definições abrangem níveis individual e organizacional; as medidas dependem do projeto.

Desfechos de implementação

A taxonomia de Proctor distingue resultados da implementação de resultados dos serviços e clínicos. Cada medida precisa indicar o que é avaliado, por quem, em que nível e momento.

Desfecho	O que investigar
Aceitabilidade	Percepção de que a prática é satisfatória.
Adoção	Intenção, decisão inicial ou início do uso.
Adequação	Percepção de pertinência e compatibilidade.
Viabilidade	Possibilidade de executar no contexto.
Fidelidade	Execução conforme previsto.
Custo	Impacto financeiro da implementação.
Penetração	Integração nos serviços e subsistemas.
Sustentabilidade	Manutenção ou institucionalização.

Prioridade de estudo da sua equipe

Viabilidade: confronte relatos com tempo de busca, faltas e execução em demandas diferentes. Custo: explicita período, perspectiva e recursos incrementais da implementação, incluindo tempo e perdas; não some toda a assistência habitual.

Não confunda as medidas

Resultado clínico: mudança na condição de saúde, como ocorrência de lesão por pressão. Resultado de serviço: qualidade ou funcionamento da assistência. Desfecho de implementação: incorporação da prática. Eles podem se relacionar, mas um não comprova os demais nem estabelece, sozinho, causalidade.

Base: Proctor et al., 2011 e 2023.

Retome a discussão

O contexto mudou

A instituição não aprovará contratação adicional neste mês. O orçamento do piloto permanece R\$ 480 e deve incluir desperdício e tempo de trabalho.

Perguntas para revisar seu raciocínio

- O plano distingue adoção inicial de execução?
- A facilitação inclui liderança, abastecimento e noturno?
- A avaliação de viabilidade e custo considera demanda, tempo e perdas?
- Qual dado sustentou a escolha? Que nova evidência faria você revisar o plano?
- Distinguiu determinante, estratégia e desfecho? Descreva um exemplo da missão.
- Como preservou os componentes essenciais e adaptou o fluxo ao contexto?

Anotações após a discussão

Registre a estratégia escolhida, uma limitação apontada na discussão, um indicador completo e o próximo passo. Retome também a devolutiva da mediação no diário do jogo.

Este resumo apresenta o caso e os conceitos; não reproduz automaticamente as decisões ou devolutivas digitadas na partida.

Meu próximo passo: _____

Evidência que ainda preciso buscar: _____

Indicador e critério de revisão: _____

Textos-base e localizadores

Graham et al., 2006. Lost in knowledge translation: time for a map?. *Journal of Continuing Education in the Health Professions*, 26(1), 13–24.

Localizador: Modelo KTA e descrição do ciclo de ação

<https://doi.org/10.1002/chp.47>

Damschroder et al., 2022. The updated Consolidated Framework for Implementation Research based on user feedback. *Implementation Science*, 17, 75.

Localizador: Tabela 3: domínios e construtos atualizados

<https://doi.org/10.1186/s13012-022-01245-0>

Reardon et al., 2025. The CFIR User Guide: a five-step guide for conducting implementation research using the framework. *Implementation Science*.

Localizador: Passos 1–3: definir domínios, coletar e analisar dados

<https://doi.org/10.1186/s13012-025-01450-7>

Harvey e Kitson, 2016. PARIHS revisited: from heuristic to integrated framework for the successful implementation of knowledge into practice. *Implementation Science*, 11, 33.

Localizador: Tabela 2, Tabela 3 e seção The facilitation construct

<https://doi.org/10.1186/s13012-016-0398-2>

Glasgow et al., 2019. RE-AIM Planning and Evaluation Framework: Adapting to New Science and Practice With a 20-Year Review. *Frontiers in Public Health*, 7, 64.

Localizador: Seção The RE-AIM dimensions: definitions, evolution, and examples

<https://doi.org/10.3389/fpubh.2019.00064>

Proctor et al., 2011. Outcomes for Implementation Research: Conceptual Distinctions, Measurement Challenges, and Research Agenda. *Administration and Policy in Mental Health*, 38, 65–76.

Localizador: Tabela 1 e seção Taxonomy of Implementation Outcomes

<https://doi.org/10.1007/s10488-010-0319-7>

Proctor et al., 2023. Ten years of implementation outcomes research: a scoping review. *Implementation Science*, 18, 31.

Localizador: Conceptualization e discussão das relações entre estratégias e desfechos

<https://doi.org/10.1186/s13012-023-01286-z>

Material preparado com auxílio de inteligência artificial. A leitura das fontes e a análise acadêmica permanecem com docentes e discentes.